

國防醫學院三軍總醫院護理部 實證護理讀書報告

日期：____年____月____日

書寫內容

1.臨床情境(Clinical Scenario)【15%】(含案例簡介、主客觀資料與評估異常值、動機、重要性)

加護病房為密閉式空間，大多病患對於醫療環境感到陌生，處在不熟悉的環境下難免情緒緊張，醫護人員交談的音量、再加上許多特殊醫療儀器(如生理監視器、呼吸器等)發出的警報聲響、更容易讓人擔憂恐懼，根據學者 Weinhouse 等(2009)的文章表示譫妄是非常常見於加護病房，尤其是老年人，會出現急性意識混亂、注意力不集中、認知障礙的情況，有時情緒較激動或是出現退化行為，若住院期間無法使病患有良好的休息品質，不但無助於病況的改善，更可能延長住院天數、增加院內感染發生率及醫療成本。

陳小姐，65 歲，因腦部多處零星中風於 5/13 入住加護病房，筆者護理期間為 5/13-5/19。入院時意識清楚，在詢問睡眠史的時候先生表示個案平時無特別睡眠問題，但半年前曾因肺炎住加護病房 7 天，因不習慣環境及吵雜的音量，連續幾個晚上沒睡好，在加護病房出現意識混亂、胡言亂語的情況，當時醫師表示為急性譫妄，開立安眠藥物使用並在兩三天後轉出加護病房，譫妄的狀況就逐漸恢復，返家後睡眠狀況良好，平均睡眠時數皆 7-8 小時。而這次再次入住加護病房病人先生擔心吵雜的環境會不會再次影響睡眠讓譫妄的情況發生？詢問有沒有預防譫妄發生的辦法？同時又可以讓病人睡得安穩？因此病人先生提出是否可以使用耳塞，減少病房噪音對病人的干擾，進而增加睡眠品質，減少急性譫妄的發生。因此引發筆者想要探討「成人加護病房病人睡覺時使用耳塞是否可降低譫妄的發生？」

2.臨床問題(Clinical Question)【3%】

成人加護病房病人睡覺時使用耳塞是否可降低譫妄的發生？

3.PICO【20%】

(1) P(5%) 成人加護病房病人

(2) I(5%) 睡覺時使用耳塞

(3) C(5%) 常規照護

(4) O(5%) 譫妄的發生率

4.問題類型【2%】

☒治療 therapy ☐診斷 diagnosis ☐預後 prognosis ☐病因 etiology ☐其他

1.關鍵字(Correct Keywords)【5%】與同義詞/醫學主題詞(Medical Subject Headings, MeSH term)【5%】

	中文關鍵字	英文關鍵字	同義詞/醫學主題詞
Patient/Population	加護病房；睡眠	Intensive care unit; sleep	Intensive Care Units[Mesh]; Sleep [Mesh]
Intervention	耳塞	Earplugs	Ear Protective Devices [Mesh]
Outcomes	譫妄	Delirium	Delirium [Mesh]

AND

AND

2. 搜尋策略【30%】

資料庫 【9%】		限制條件【5%】	篇數 【5%】	篇名符合	刪除重複	內容符合
				註：由標題及摘要檢視，排除不符合PICOS文章，剩餘符合之總篇數	註：刪除重複文章後剩餘篇數	註：由內容檢視，排除不符合納入條件之文章，最後可納入評讀之篇數
二級資料庫 (3%)	☐ UpToDate	■年代 2012-2017 ☐ 語言 ☐ 族群 ☐ 年齡 ■研究設計 Systematic review and meta-analysis ■其他，請說明 <u>布林字元</u>	1	1	0	1
	☐ ACP Journal Club					
	☐ DynaMed					
	☒ Cochrane Library					
	☐ Nursing Consult					
	☐ DARE					
	☐ 其他					
一級資料庫 (3%)	☒ PubMed		2	1	0	1
	☐ MEDLINE					
	☐ CINAHL					
	☐ SUMsearch					
	☐ TRIP					
本土資料庫 (3%)	☒ CEPS		0	0	0	0
	☐ 健保署					
	☐ 其他					

納入條件(Inclusion Criteria) (3%)：

依據篩選與限制，篩選五年內，並且研究設計為 Systematic review 及 meta-analysis，並且依照關鍵字進行搜尋，搜尋電子資料庫一個二級資料庫、一級資料庫及本土資料庫後，共納入兩篇文獻。

排除條件(Exclusion Criteria)(3%)：

排除一篇文獻因此文獻中研究方法耳塞非主要介入措施，對象涵括兒童，且年份較久遠(2012)，且已經被本篇預計評讀的系統性文獻回顧納入其中故予以排除。

搜尋資料庫畫面(Database Search Screen)【請另紙檢附「查詢歷史」(History)】【5%】

(三) 評 讀 文 獻 20%	文獻摘要(Abstract)【20%】 參考文獻(Reference)(4%)：主要評讀文獻(請依 APA 最新格式書寫參考資料) Edward, L., Vanessa, C., Rosalind, E., & Steve, A. R. W. (2016). The Efficacy of Earplugs as a Sleep Hygiene Strategy for Reducing Delirium in the ICU: A Systematic Review and Meta-Analysis. Critical Care Medicine, 44(5), 992-999. 對象 (Patients/Problem) (4%)： 本文進行了文獻系統分析 (Systematic review) 和統合分析(Meta-analysis)，搜索策略以主要醫學資料庫 MEDLINE、EMBASE 和 Cochrane，檢索關鍵字以“重症照護”(Critical care) (Intensive care)、“耳塞(Earplugs)”、“睡眠(Sleep)”、“睡眠障礙(Sleep disorders)”和“譫妄(Delirium)”。初始搜索時間範圍於 1966 年和 5 月到 2015 年，沒有進行語言限制。之後於 2015 年 7 月再次將資料統整，並無額外研究資料納入。經過篩選後從 2009 年至 2015 年間選出已發表的九篇研究文獻，總共包括 1,455 名參與研究之受試者符合資格標準，並被納入系統評價。九篇入選文獻當中，以耳塞作為單獨的介入措施之文獻共有三篇(n=3)，或作為眼罩的一部分介入措施共有兩篇(n=2)，耳塞、眼罩和額外的睡眠噪聲消除策略等介入措施涵蓋之文獻共有 4 篇(n=4)。研究對象主要包含入住加護病房的病人，若是健康的自願者則不會納入研究中。 措施 (Intervention) (4%)： 其主要目的為評估耳塞運用在ICU病人是否可減少譫妄的發生。 比較 (Comparison) (4%)： 無使用介入措施作為比較。 結果 (Outcome) (4%)： 在本文研究中，病患入住加護病房後實施了睡眠衛生包括放置耳塞，結果顯示可顯著降低譫妄發生風險。符合耳塞放置條件簡易，且目前研究報告表示無任何安全問題。幾篇證據等級較高之文獻說明了此項介入措施對於加護病房病人是有益處的。嚴重疾病患者在入住加護病房期間發生睡眠中斷幾乎是非常普遍的，然而耳塞目前無明確列入加護病房護理照護活動之中。做為一個安全和簡單的介入措施，本文的研究結果表明，耳塞可降低噪音，改善睡眠衛生。研究結果病房有發現耳塞與死亡率有正相關性。雖然譫妄是否與增加的發病率和死亡率目前尚無定論，然而，使用便宜簡單、無害的介入措施，提高睡眠品質，並降低譫妄的發生率和減少加護病房住院時間和成本。
---	---

備註：篇幅限 12 號字體，單行間距，欄位如不足，請自行延伸，頁數勿超過 4 頁(不含搜尋資料庫畫面)；另請檢附搜尋資料庫畫面。